Chương 1

Tăng huyết áp

Điểm chính

Tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ tim mạch có thể thay đổi được, phổ biến nhất trên thế giới.

Chẩn đoán dựa trên nhiều lần đo đúng kỹ thuật, nên kết hợp đo huyết áp tại nhà hoặc Holter 24 giờ.

Thay đổi lối sống là nền tảng; phần lớn người bệnh cần phối hợp từ hai thuốc trở lên để đạt mục tiêu.

Đại cương

Tăng huyết áp (THA) được định nghĩa khi huyết áp tâm thu đo tại phòng khám ≥ 140 mmHg và/hoặc huyết áp tâm trương ≥ 90 mmHg, sau nhiều lần đo đúng kỹ thuật[1]. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, khoảng 1,28 tỷ người trưởng thành từ 30 đến 79 tuổi mắc THA, và gần một nửa trong số đó không biết mình mắc bệnh[2].

THA thường không có triệu chứng trong nhiều năm, vì vậy được gọi là "kẻ giết người thầm lặng". Bệnh làm tăng nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim, suy tim, bệnh thận mạn và sa sút trí tuệ. Giảm 10 mmHg huyết áp tâm thu giúp giảm đáng kể các biến cố tim mạch lớn.

Về sinh lý bệnh, huyết áp phụ thuộc vào cung lượng tim và sức cản mạch ngoại biên. Hệ renin–angiotensin–aldosteron (RAA), hệ thần kinh giao cảm, sự ứ natri (Na^+) và rối loạn chức năng nội mô đều tham gia vào cơ chế bệnh sinh.

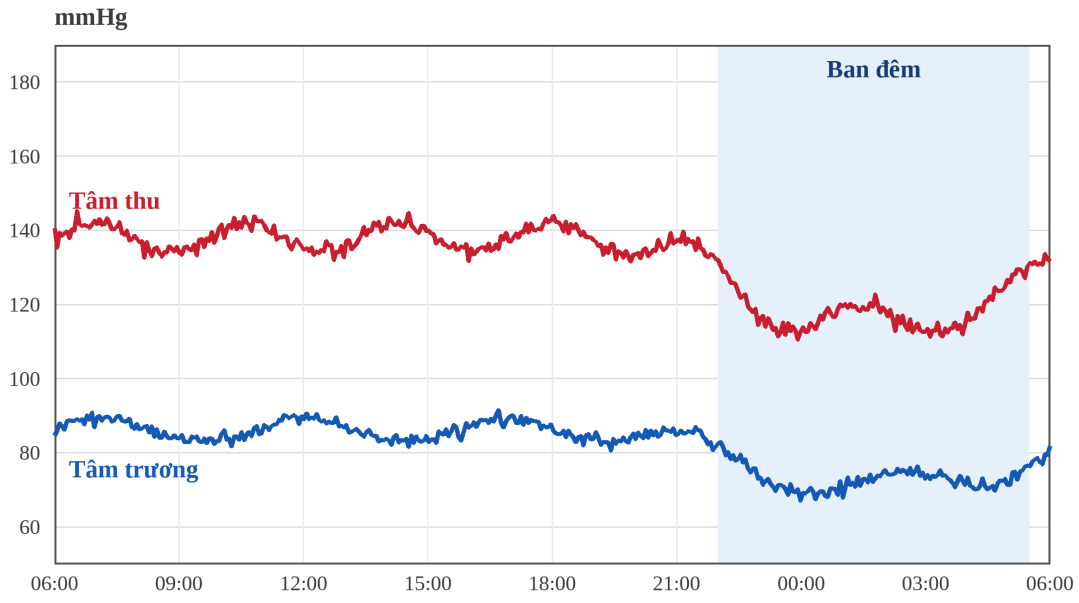
Phân loại

Phân loại theo trị số huyết áp đo tại phòng khám được trình bày trong Bảng 1.1. Khi huyết áp tâm thu và tâm trương thuộc hai mức khác nhau, xếp theo mức cao hơn.

Bảng 1.1. Phân loại huyết áp đo tại phòng khám (mmHg)

Phân loại	Tâm thu		Tâm trương
Tối ưu	< 120	và	< 80
Bình thường	120–129	và/hoặc	80–84
Bình thường cao	130–139	và/hoặc	85–89
THA độ 1	140–159	và/hoặc	90–99
THA độ 2	160–179	và/hoặc	100–109
THA độ 3	≥ 180	và/hoặc	≥ 110
THA tâm thu đơn độc	≥ 140	và	< 90

Huyết áp dao động theo nhịp ngày đêm: thường giảm 10–20% khi ngủ. Mất trũng huyết áp ban đêm ("non-dipper") liên quan đến tăng nguy cơ tim mạch (Hình 1.1).



Hình 1.1. Biến thiên huyết áp trong 24 giờ ở người có trũng huyết áp ban đêm bình thường (ảnh minh họa).

Chẩn đoán

Đo huyết áp đúng kỹ thuật

Sai số khi đo là nguyên nhân thường gặp của chẩn đoán sai. Quy trình đo tại phòng khám gồm các bước:

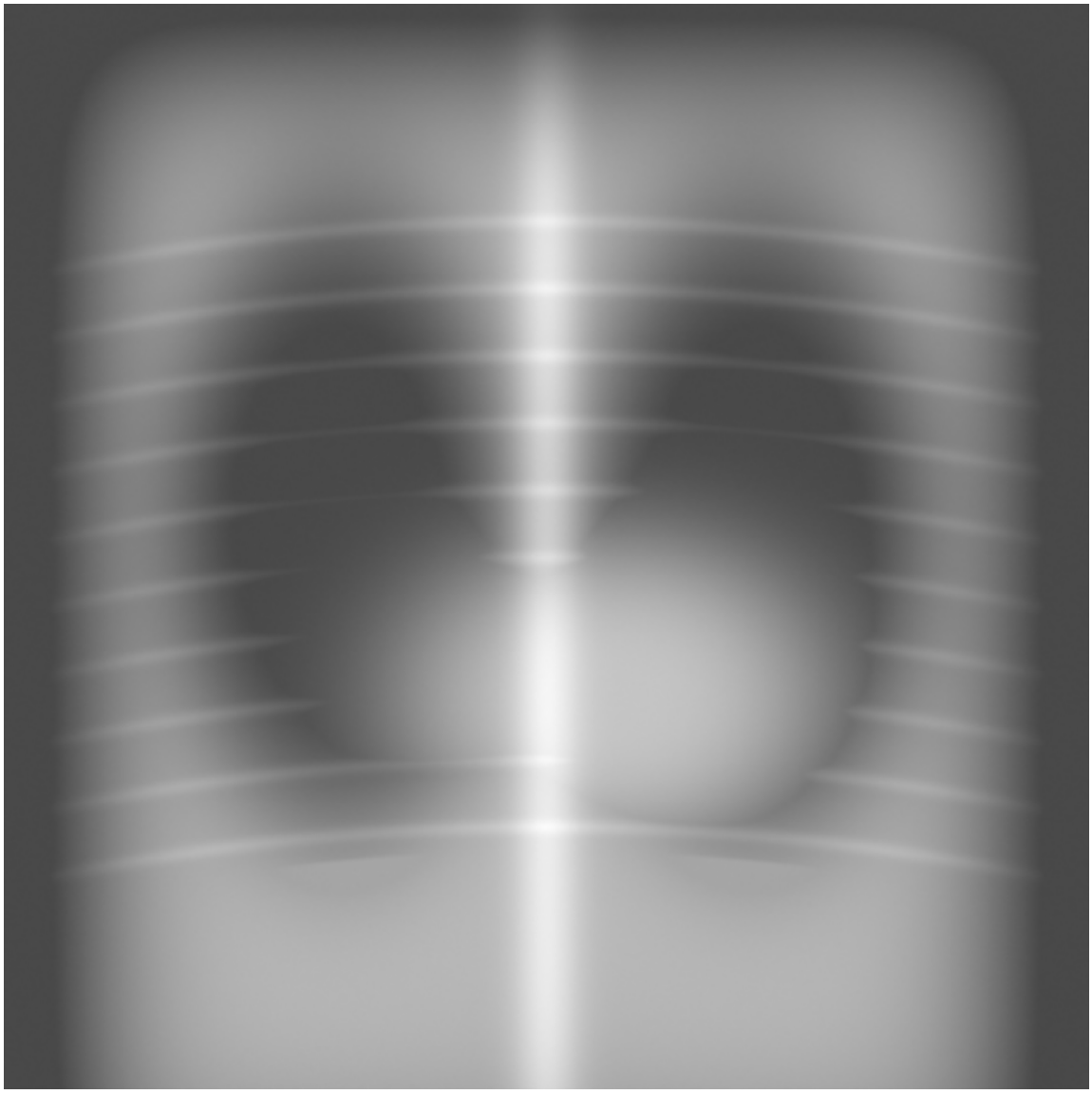
1. Người bệnh ngồi nghỉ 3–5 phút trong phòng yên tĩnh, không hút thuốc hay uống cà phê trong 30 phút trước đó.
2. Dùng băng quấn phù hợp với chu vi cánh tay; đặt băng quấn ngang mức tim.
3. Đo 3 lần, cách nhau 1–2 phút; lấy trung bình của 2 lần cuối.
4. Lần khám đầu tiên đo cả hai tay; các lần sau đo ở tay có trị số cao hơn.

Đánh giá tổn thương cơ quan đích

Cần tìm các tổn thương do THA gây ra, vì chúng làm thay đổi phân tầng nguy cơ và lựa chọn điều trị:

- Tim: phì đại thất trái trên điện tâm đồ hoặc siêu âm tim.
- Thận: mức lọc cầu thận ước tính (eGFR) giảm, albumin niệu.
- Mạch máu: mảng xơ vữa động mạch cảnh, chỉ số cổ chân–cánh tay thấp.
- Mắt: bệnh võng mạc do THA (xuất huyết, xuất tiết, phù gai thị).

Chụp X-quang ngực có thể thấy bóng tim to ở người bệnh THA lâu năm (Hình 1.2), tuy nhiên đây là dấu hiệu muộn và kém nhạy.



Hình 1.2. Phim X-quang ngực thẳng: bóng tim to (ảnh tổng hợp dùng cho minh họa).

Điều trị

Thay đổi lối sống

- Giảm muối: dưới 5 g muối mỗi ngày.
- Tăng rau quả, chế độ ăn kiểu DASH hoặc Địa Trung Hải.
- Giảm cân nếu thừa cân; duy trì vòng eo hợp lý.
- Hoạt động thể lực mức trung bình ít nhất 150 phút mỗi tuần.
- Hạn chế rượu bia, bỏ hoàn toàn thuốc lá.

Thuốc hạ huyết áp

Năm nhóm thuốc chính có bằng chứng giảm biến cố tim mạch gồm: ức chế men chuyển (ƯCMC), chẹn thụ thể angiotensin II (CTTA), chẹn kênh canxi (CKCa), lợi tiểu thiazid hoặc giống thiazid, và chẹn beta. Với đa số người bệnh, nên khởi đầu bằng phối hợp hai thuốc trong một viên.

Bảng 1.2. Một số thuốc hạ huyết áp thường dùng (liều tham khảo cho người lớn)

Nhóm	Thuốc	Liều hằng ngày	Lưu ý
ƯCMC	Lisinopril	10–40 mg	Ho khan, phù mạch; chống chỉ định khi có thai
CTTA	Losartan	50–100 mg	Theo dõi kali máu và creatinin
CKCa	Amlodipin	5–10 mg	Phù cổ chân
Lợi tiểu	Indapamid SR	1,5 mg	Hạ kali, tăng acid uric
Chẹn beta	Bisoprolol	2,5–10 mg	Ưu tiên khi có suy tim, bệnh mạch vành

> *Lưu ý: không phối hợp ƯCMC với CTTA vì tăng nguy cơ tăng kali máu và tổn thương thận cấp mà không thêm lợi ích.*

Mục tiêu điều trị chung là huyết áp phòng khám < 140/90 mmHg, và nếu dung nạp tốt thì hạ xuống khoảng 120–130/70–80 mmHg ở phần lớn người bệnh dưới 65 tuổi.

Tài liệu tham khảo

1. Williams B, Mancia G, Spiering W, et al. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur Heart J. 2018;39(33):3021–3104.
2. World Health Organization. Global report on hypertension: the race against a silent killer. Geneva: WHO; 2023.

[1] Ngưỡng chẩn đoán theo Hướng dẫn ESC/ESH 2018.

[2] Số liệu trong Báo cáo toàn cầu về tăng huyết áp của WHO năm 2023.

Chương 2

Đái tháo đường type 2

Đại cương

Đái tháo đường type 2 (ĐTĐ type 2) là rối loạn chuyển hóa mạn tính đặc trưng bởi tăng glucose máu, do kết hợp giữa đề kháng insulin và suy giảm tiến triển chức năng tế bào beta tụy. Đây là thể bệnh chiếm khoảng 90% số người mắc đái tháo đường.

Các yếu tố nguy cơ chính gồm thừa cân, béo bụng, ít vận động, tiền sử gia đình, tiền sử đái tháo đường thai kỳ và tuổi cao. Tăng glucose máu kéo dài gây biến chứng mạch máu nhỏ (võng mạc, thận, thần kinh) và mạch máu lớn (bệnh mạch vành, đột quỵ, bệnh động mạch ngoại biên).

Chẩn đoán

Chẩn đoán đái tháo đường khi có một trong các tiêu chuẩn trong Bảng 2.1[1]. Nếu không có triệu chứng tăng glucose máu rõ ràng, cần xét nghiệm lại lần hai để khẳng định.

Bảng 2.1. Tiêu chuẩn chẩn đoán đái tháo đường

Xét nghiệm	Ngưỡng chẩn đoán
HbA_{1c}	≥ 6,5% (48 mmol/mol)
Glucose huyết tương lúc đói (nhịn ăn ≥ 8 giờ)	≥ 126 mg/dL (7,0 mmol/L)
Glucose huyết tương 2 giờ sau nghiệm pháp dung nạp 75 g glucose	≥ 200 mg/dL (11,1 mmol/L)
Glucose huyết tương bất kỳ, kèm triệu chứng kinh điển	≥ 200 mg/dL (11,1 mmol/L)

Triệu chứng kinh điển gồm uống nhiều, tiểu nhiều, ăn nhiều và sụt cân không rõ nguyên nhân. Xét nghiệm HbA_{1c} có thể sai lệch khi người bệnh thiếu máu, có bệnh huyết sắc tố hoặc mới truyền máu.

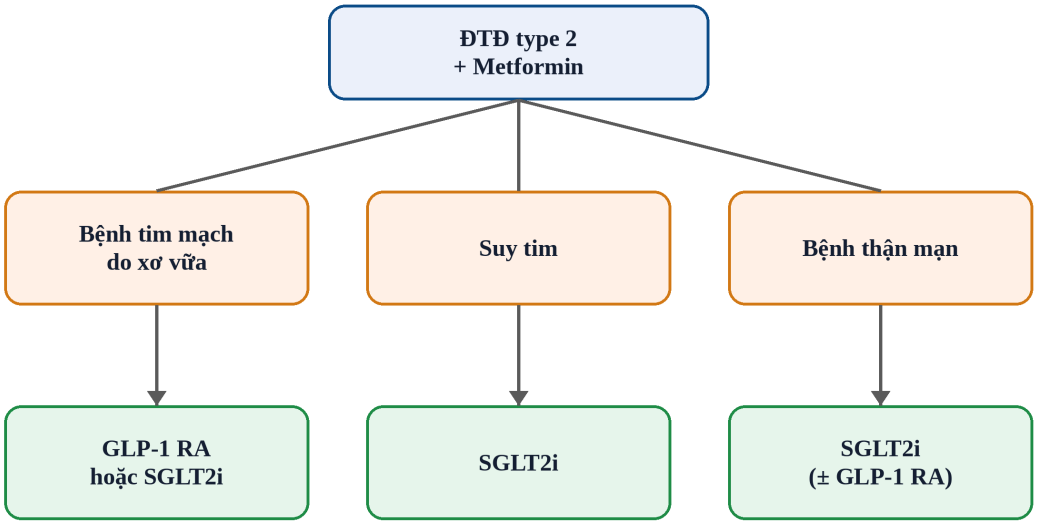
Điều trị

Nguyên tắc chung

Điều trị lấy người bệnh làm trung tâm: mục tiêu HbA_{1c} thường < 7%, có thể nới lỏng ở người cao tuổi, nhiều bệnh kèm theo hoặc dễ bị hạ glucose máu. Bên cạnh kiểm soát glucose, cần kiểm soát đồng thời huyết áp, lipid máu và cân nặng.

Lựa chọn thuốc

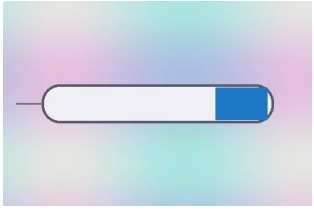
Metformin vẫn là thuốc nền tảng cho phần lớn người bệnh nếu không có chống chỉ định. Ở người bệnh có bệnh tim mạch do xơ vữa, suy tim hoặc bệnh thận mạn, ưu tiên thuốc ức chế SGLT2 hoặc đồng vận thụ thể GLP-1 có lợi ích tim–thận đã được chứng minh, độc lập với mức HbA_{1c} (Hình 2.1).



Hình 2.1. Sơ đồ lựa chọn thuốc theo bệnh đồng mắc (sơ đồ minh họa).

1. Có bệnh tim mạch do xơ vữa: ưu tiên đồng vận GLP-1 hoặc ức chế SGLT2.
2. Có suy tim: ưu tiên ức chế SGLT2.
3. Có bệnh thận mạn: ưu tiên ức chế SGLT2; dùng đồng vận GLP-1 nếu không dung nạp.
4. Cần giảm cân nhiều: cân nhắc đồng vận GLP-1 hoặc đồng vận kép GIP/GLP-1.

Insulin được chỉ định khi HbA_{1c} rất cao (thường > 10%), có triệu chứng dị hóa rõ hoặc khi các thuốc khác không đạt mục tiêu.



Hình 2.2. Bút tiêm insulin (ảnh chụp từ bản thảo, độ phân giải thấp).

Tài liệu tham khảo

1. American Diabetes Association Professional Practice Committee. 2. Diagnosis and Classification of Diabetes: Standards of Care in Diabetes—2024. Diabetes Care. 2024;47(Suppl 1):S20–S42.

[1] Theo Tiêu chuẩn chăm sóc đái tháo đường của Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ (ADA) năm 2024.